随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

10. 2025N5 A 在心动周期中，可导致舒张期心室充盈增加的因素是

A.心肌纤维化 顺应性↓ →舒张速度↓ →抽吸减弱,回心血量↓

B.直立体位 重力原因

C.舒张期心肌细胞外 Na^+浓度增加 未提及

D.舒张期心肌细胞胞质 Ca^{2+}浓度回降加快 →舒张速度↑ →抽吸增强,回心血量↑

专题串联·静脉回心血量的影响因素

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

表格左列均导致**回心血量↑**（强化切入点，切入点解决因果混淆、主次矛盾等问题）	
右心射血能力↑	**舒张期室内压↓**→抽吸右心房↑→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 按压患者肿大的肝脏，颈静脉怒张更明显 串：右心衰（右心射血能力↓）致肝颈静脉回流征 旧的不去新的不来
吸气 才能让V/Q匹配 胸腔负压 又吸气又吸血	**胸腔负压↑**→右心房和胸腔大静脉扩张→**CVP↓**→抽吸静脉↑→回心血量↑ 吸气相 CVP↓、呼气相 CVP 回升（呼吸频率 12-18 次/分、心率 60-100 次/分，血液不会一直在右心房）
血容量↑	若大失血→血容量↓→回心血量↓
舒张期 Ca^{2+} 回降速度↑	舒张速度↑→抽吸↑（舒张越快压力下降越多）→回心血量↑ HBP早期心肌C肥大(顺应性↓),未影响钙离子回降 串：冠心病早期可为舒张性心衰，冠脉硬化→心肌缺血→心肌能量↓→胞质 Ca^{2+}不能及时回收入肌浆网和排出细胞外→心室主动舒张功能障碍
心率↓	若心率＞180→心室充盈↓→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→心输出量↓ 没血干跳
心包压力↓	串：心包积液、缩窄性心包炎→心包压力↑→心室充盈↓→回心血量↓ 限制心脏舒张
顺应性↑	串：心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→主要使舒张速度↓→回心血量↓ 胖胖不灵活
输液过多过快	串：输液过多过快可诱发心衰 单位时间内血管里血量增加→回心血量增加
直立变平卧	①若平卧变直立、或下蹲变直立→回心血量↓（身体低垂部分的静脉因重力跨过管壁的压力,管里装的东西多→跨壁压增大跨壁压增大而扩张）→可因脑缺血而眼前发黑甚至昏厥 ②心衰可有夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸 夜间平躺回心血量增加,被迫坐起来减少回心血量 ③休克时将头和下肢抬高可增加回心血量 ↘ ↙ 促进回心血量
微动脉舒张	
静脉收缩	串：硝酸酯类药扩静脉→回心血量↓（静脉要收缩才能挤回去血）
走路跑步	即骨骼肌挤压的肌肉泵作用。需注意**骨骼肌持续紧张性收缩**（不是节律性舒缩）→**回心血量↓**（久站头晕）
站在深水里	水的密度比空气大→水压起到类似肌肉泵的作用

思维导图·血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:10 D